UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'EC
OS

HÉMATOLOGIE
Myélome multiple
Sans patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : William Bouregba Date de rédaction :

09/12/2023

Situation de départ N°193 – Analyse de l'électrophorèse des protéines sériques

Domaine de compétence n°1 : Stratégie diagnostique

Domaine de compétence n°1 : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1-Organiser son raisonnement et hiérarchiser les hypothèses diagnostiques
2-Prescrire de manière raisonnée les explorations complémentaires
3-Évaluer le degrés d'urgence de la prise en charge

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- Bilan sanguin + électrophorèse des protéines sériques

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'EC
OS

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en hématologie à l'hôpital de l'Archet.

Vous recevez Monsieur E., 67 ans, s'étant initialement présenté aux urgences pour des douleurs osseuses et une polyurie évoluant depuis 3 semaines. Le patient vous est transféré par un collègue urgentiste pour anomalies au bilan sanguin et à l'électrophorèse des protéines sériques.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Décrire les examens complémentaires et donner le diagnostic le plus probable dans le contexte
2. Enoncer la prise en charge diagnostique
3. Enoncer la prise en charge thérapeutique dans l'immédiat

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'EC
OS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1	
Dit qu'il s'agit d'une hypercalcémie symptomatique	
Calcule la calcémie corrigée	
Enonce la normalité du reste des examens	
Dit qu'il existe un pic d'allure monoclonal dans la zone des gammaglobulines	
Synthétise le cas et évoque le diagnostic de myélome multiple symptomatique	
Tâche 2	
Demande une immunofixation des protéines sériques ET un myélogramme	
Demande des radiographies centrées sur les zones douloureuses	
Demande un scanner corps entier NON INJECTÉ	
Demande un TEP scanner au 18 fluorodésoxyglucose	
Demande un bilan urinaire exhaustif (*une protéinurie des 24 heures, une électrophorèse et une immunofixation des protéines urinaires*) OK si 2/3	
Tâche 3	
Enonce l'urgence thérapeutique	
Demande un ECG	
Prescrit une réhydratation au sérum physiologique IV	
Prescrit des biphosphonates IV	
Prescrit une corticothérapie IV	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5
Aptitude à planifier les soins	
Aptitude à proposer une prise en charge	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'EC
OS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tâche 1	
Dit qu'il s'agit d'une hypercalcémie symptomatique	2
Calcule la calcémie corrigée	1
Identifie qu'il s'agit d'une urgence métabolique	1
Dit qu'il existe un pic d'allure monoclonal dans la zone des gammaglobulines	2
Synthétise le cas et évoque le diagnostic de myélome multiple symptomatique	4
Tâche 2	
Demande une immunofixation des protéines sériques et un myélogramme	4
Demande des radiographies centrées sur les zones douloureuses	2
Demande un scanner corps entier NON INJECTÉ	4
Demande un TEP scanner au 18 fluorodésoxyglucose	4
Demande un bilan urinaire exhaustif (une protéinurie des 24h, une électrophorèse et une immunofixation des protéines urinaires)	6
Tâche 3	
Demande un ECG	4
Prescrit une réhydratation au sérum salé isotonique IV	4
Prescrit des biphosphonates IV	1
Prescrit une corticothérapie IV	1
TOTALE	**/40**
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 4
Aptitude à planifier les soins	1 à 3
Aptitude à proposer une prise en charge	1 à 3
NOTE TOTALE	**/50**

3
1
8
0

Leucocytes	5.34	giga/L
Hématies	↓ 4.41	téra/L
Hémoglobine	147.0	g/L
Hématocrite	42.0	%
VGM	94.3	fL
TCMH	↑33.3	pg
CCMH	353	g/L
IDR-CV	12.90	%
Plaquettes	175	giga/L
Polynucléaires neutrophiles %	↑74.6	%
Polynucléaires neutrophiles	3.98	giga/L
Polynucléaires éosinophiles %	1.7	%
Polynucléaires éosinophiles	0.09	giga/L
Polynucléaires basophiles %	0.6	%
Polynucléaires basophiles	0.03	giga/L
Lymphocytes %	↓ 14.8	%
Lymphocytes	↓ 0.79	giga/L
Monocytes %	7.7	%
Monocytes	0.41	giga/L

Sodium *Potentiométrie indirecte Architect Abbott*	140	mmol/L
Potassium *Potentiométrie indirecte Architect Abbott*	3.9	mmol/L
Chlore *Potentiométrie indirecte Architect Abbott*	↑109	mmol/L
Bicarbonates *Méthode enzymatique UV Architect Abbott*	23	mmol/L
Trou anionique	12.0	mmol/L
Urée *Méthode enzymatique UV cinétique Architect Abbott*	6.4	mmol/L
Créatinine *Méthode enzymatique Architect Abbott*	84	µmol/L
Estimation du DFG par CKD-EPI	↓ 74	mL/min/1.73m²
Protéines *Méthode au Biuret / KI Architect Abbott*	↑84	g/L
Glucose *Méthode Hexokinase Architect Abbott*	4.4	mmol/L
Calcium *Photométrie Arsenazo III Architect Abbott*	2.27	mmol/L
Phosphore *Photométrie UV Architect Abbott*	0.77	mmol/L
Acide urique *Méthode enzymatique Uricase / AOD Architect Abbott*	↑541	µmol/L
Magnésium *Méthode enzymatique Architect Abbott*	0.80	mmol/L
CRP *Immunoturbidimétrie Architect Abbott*	3.6	mg/L

UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR
FACULTÉ
DE MÉDECINE

TUT'ECOS